EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 73680
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-11-07 09:59:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ERIKA JACQUELINE PARRA MU►OZ			RUN	: 11.200.877-2
F.Nac	: 24-12-1966	Edad	: 56 AÑOS, 10 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: CHACABUCO 189			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-11-04	Fecha Egreso	: 2023-11-07 09:59:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A81.0-ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. F02.1-DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- Hipertensión arterial
- Resistencia insulina
- Dislipidemia
- Asma bronquial
- Hipotiroidismo
- T depresivo

Antecedentes quirúrgicos:
- Retinaculoplastia

Alergias:
- Sin antecedentes de alergia a medicamentos

Medicamentos:
- Amlodipino 5 Mg al dia
- Atorvastatina 20 Mg 1/2 comp al día
- Levotiroxina 50 Mcg al día
- Losartan 50 mg cada 12 horas
- Metformina 850 Mg al día
- Omeprazol 20 Mg al día

Hábitos:
- Tabaco (+) 8-10 cigarros al día
- OH (+)
- Drogas (-)

Diestro mRS3
Paciente con antecedente de hermano fallecido por CJD, y en su familia al menos otros 5 familiares con fallecimientos en el mismo contexto.
Con cuadro de al menos 2-3 meses de evolución consistentes en bradipsiquia, episodios confusionales, asociado eventos aislados de anomia y apraxia. Con progresión mas importante en ultimo mes principalmente con alteración de la marcha.
Evaluada en SU de HSC el 25/09/2023 por episodio confusional se deriva a CAE neurología y se solicitó RM de encéfalo.

En evaluación por neurología del 04/10/23 con RM de encéfalo realizada el 26/09/23 con alteración de señal de la sustancia gris ganglionar bilateral con predominio izquierdo, de la corteza cingulada anterior bilateral y frontoinsular izquierda, con restricción a la difusión e hiperseñal T2; hallazgos compatibles con ECJ. Se solicita resto de estudio.
- 18/10/23 ANA, perfil ENA, ANCA, antiDNA y SAF (-)
Se hospitaliza el 31/10/23 traida por SAMU por cuadro convulsivos en domicilio.
Se toma conocimiento del caso el 06/11/23 se realiza estudio de LCR normal, se realizó EEG con patrón de descargas lateralizadas periódicas y presencia de ondas trifásicas con base disfuncional. Cursa con status mioclónico que se yugula con benzodiacepinas y aumento de FAE.
Se conversa con familia y se acuerda en conjunto que considerando antecedentes familiares, cuadro clínico actual, hallazgos de resonancia magnética y patrón de electroencefalograma, se considera ingreso a cuidados paliativos y seguimiento por hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo en cama, colchon antiescaras y cambios de posición cada 3-4 horas..
2. Régimen osmolite 300 cc por 4 veces
3. Agua por SNG 300 cc por 4 veces
4. Levetiracetam 500 mg, 4 comp cada 12 horas por SNG
5. Acido valproico 500 mg, 2 comp cada 12 ohras por SNG
6. Clobazam 10 mg, 1 cada 12 horas por SNG
7. Midazolam 5 mg, 1/2 amp cada 12 horas, SC
8. Morfina 10 mg, 1/2 amp cada 6 horas, SC
9. Lactulosa 20 cc por 4 veces por SNG
10. Evaluación e ingreso a cuidados paliativos universales

EXÁMENES Y RESULTADOS

Examenes de relevancia
- 06/11/23 Creat 0.8, MDRD 74.2, Uremia 124, BUN 58, ELP 148/3.9/113, Hb 12.8, Hto 39.7, Leuco 20000, plaq 332.000, VHS 36, PCR 44.5
- 06/11/23 LCR glucosa 106 (HGT 156), prot 22, lactato 2.1, alb 8.1, leuco 1.1. Gram sin bacterias. panel PCR meningitis encefalitis pendiente. Cultivo LCR pendiente
- 06/11/23 EEG st descargas lateralizadas periódicas y presencia de ondas trifásicas con base disfuncional. Preinforme
- 05/11/23 Creat 0.7, MDRD 86.56, Uremia 88, BUN 41, ELP 145/3.9/108, Hb 13.3, Hto 41.6, Leuco 15300, plaq 418.000, VHS59, PCR 63, OC no inflamatoria, UC negativo. INR 1.18. TTPa 30
- 04/11/23 HC I y II negativo a la fecha
- 16/10/23 TSH 3.9, T4L 0.76, marcadores tumorales negativos, AFP (-), Ca125 (-), Ca19-9 (-), CEA (-), VitB12 287, VitD 13.0. HIV (-), VDRL (-), HBV (-), HCV (-)
- 26/09/23 RM de encéfalo con contraste: Alteración de señal de la sustancia gris ganglionar bilateral con predominio izquierdo, de la corteza cingulada
anterior bilateral y frontoinsular izquierda, con restricción a la difusión e hiperseñal T2; hallazgos compatibles con ECJ

OBSERVACIONES:

- Mental: apertura ocular al dolor, no emite lenguaje, no sigue ordenes ni se conecta con evaluador. Hiperecplexia intensa.
- PC: pupilas isocoricas, RFM +/+, CV impresiona hemianopsia derecha, OCM por OC impresiona indemne, sensibilidad facial algésica conservada, facie simétrica. Resto no evaluable.
- Motor-sensitivo: Mioclonias esporádicas mayor en HC derecho. al dolor retira ESI y EII, resto sin respuesta.
- Cerebelo: no evaluable
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO